

TEMA 1.47 • CARDIOLOGÍA

Insuficiencia Venosa de Extremidades Inferiores

PERFIL EUNACOM 1.02.1.019
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)**, manifestada frecuentemente como **várices** de extremidades inferiores, es una patología extremadamente común en la práctica clínica. Se produce por la incapacidad de las venas para retornar la sangre de forma eficiente hacia el corazón, generalmente debido a una disfunción valvular o debilidad de la pared venosa.

Clínica y Diagnóstico

El diagnóstico de la insuficiencia venosa es fundamentalmente **clínico**. Los hallazgos típicos incluyen:

- **Várices:** Venas superficiales dilatadas y tortuosas.
- **Telangiectasias venosas:** Pequeñas dilataciones vasculares de color violáceo (comúnmente llamadas "arañitas").
- **Edema:** Puede ser simétrico o asimétrico, pero siempre es de **instalación crónica**.
- **Cambios tróficos de la piel:** La piel se vuelve más gruesa y adquiere un color oscuro o café, proceso conocido como **lipodermatoesclerosis**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta un **edema de instalación aguda y asimétrico**, la prioridad absoluta es descartar una **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**, ya que es una condición de mayor riesgo vital.

Úlceras Venosas vs. Arteriales

Uno de los puntos más preguntados en el examen es la diferenciación entre las úlceras de origen venoso y las de origen arterial.

TABLA 1.47.1: CARACTERÍSTICA VS ÚLCERA VENOSA		
CARACTERÍSTICA	ÚLCERA VENOSA	ÚLCERA ARTERIAL
Dolor	Habitualmente indolora	Muy dolorosa
Color	Violáceo / Eritematoso	Pálida / Isquémica
Localización	Maléolo interno	Maléolo externo o zonas distales (dedos)
Piel circundante	Lipodermatoesclerosis (oscura/gruesa)	Piel fina, brillante, sin vellos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda la tríada clásica de la úlcera venosa para el EUNACOM: **Indolora, color violáceo y ubicada en el maléolo interno.**

Manejo de la Insuficiencia Venosa

El tratamiento inicial suele ser conservador y no invasivo, enfocado en mejorar el retorno venoso.

1. Manejo No Invasivo (Conservador)

- **Compresión elástica:** Uso de medias de compresión o vendajes elásticos. Es el pilar del tratamiento. - **Ejercicios de fortalecimiento:** Potenciar la musculatura de las pantorrillas (bomba muscular) para asistir el retorno sanguíneo. - **Elevación de extremidades:** Mantener las piernas en alto durante el descanso. - **Cuidado de úlceras:** Curaciones locales.

NOTA CLÍNICA

Las úlceras venosas **no requieren antibióticos** de forma rutinaria, a menos que existan signos evidentes de sobreinfección bacteriana (celulitis, exudado purulento, aumento de calor local).

2. Manejo Invasivo y Quirúrgico

Se reserva para casos graves, sintomáticos o con úlceras que no responden al tratamiento conservador:

- **Ablación venosa:** Procedimiento mínimamente invasivo mediante radiofrecuencia o catéter endovascular para destruir las venas afectadas.
- **Ablación de perforantes:** Dirigido específicamente a las venas que comunican el sistema superficial con el profundo cuando estas son incompetentes.
- **Cirugía (Safenectomía):** Extirpación quirúrgica de las venas safenas insuficientes cuando las técnicas anteriores fallan o no están indicadas.

Complicaciones: Varicorrugia

La **varicorrugia** es el sangrado de una vena varicosa, ya sea de forma espontánea o por un traumatismo mínimo.

- **Algoritmo de manejo:**
- **Compresión externa:** Es la medida inicial y más importante. Suele ser suficiente para controlar el sangrado.
- **Sutura:** Si la compresión no detiene la hemorragia, se realiza una sutura simple del punto sangrante.
- **Cirugía de urgencia:** En casos excepcionales donde no se logra hemostasia, se procede a la ligadura de la safena o safenectomía según la localización.

Consideraciones Estéticas

Muchos pacientes consultan por la apariencia de las telangiectasias o várices sin presentar síntomas graves. En estos casos: - Se deben evaluar riesgos y beneficios junto al paciente. - El manejo puede ir desde medidas conservadoras (medias) hasta ablación o cirugía, dependiendo de la severidad estética y la autopercepción del paciente.

Insuficiencia Cardíaca Trombosis Venosa Profunda

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 55 años consulta por úlcera en cara medial del maléolo izquierdo de 3 meses de evolución, poco dolorosa, con fondo granulante y bordes irregulares. Presenta edema vespertino, várices, dermatitis ocre y lipodermatoesclerosis en pierna ipsilateral."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Úlcera venosa crónica por insuficiencia venosa avanzada (clasificación CEAP C6). Características: perimalleolar medial, poco dolorosa, fondo granulante. Diagnóstico diferencial con úlcera arterial (distal, muy dolorosa, fondo pálido). Tratamiento: Compresión elástica gradual multicapa (pilar fundamental) + Curación avanzada de heridas + Pentoxifilina. Prevenir TVP con deambulación precoz.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La IVC se produce por incompetencia valvular con hipertensión venosa crónica
- La clasificación CEAP va de C0 (sin signos) a C6 (úlceras activas)
- La dermatitis ocre es pigmentación parda por depósito de hemosiderina
- La úlcera venosa es perimaleolar medial, irregular, poco dolorosa con fondo granulante
- La úlcera arterial es distal, regular, dolorosa con fondo pálido
- La compresión elástica es el pilar del tratamiento conservador
- La ablación endovenosa (láser/RF) es el procedimiento de elección para safena incompetente
- El tratamiento clave de la úlcera venosa es la compresión multicapa

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA VENOSA DE EXTREMIDADES INFERIORES)**PREGUNTA 1**

Mujer de 55 años consulta por una úlcera en la cara medial del maléolo izquierdo de 2 meses de evolución. Presenta pigmentación parda perilesional, edema vespertino y várices. La úlcera tiene bordes irregulares y fondo granulante. ¿Cuál es el diagnóstico y el pilar del tratamiento?

- A)** Úlcera arterial; revascularización urgente
- B)** Úlcera venosa; compresión multicapa
- C)** Úlcera neuropática; descarga del pie
- D)** Úlcera neoplásica; biopsia urgente
- E)** Celulitis; antibióticos sistémicos

PREGUNTA 2

¿Cuál es la diferencia principal entre úlcera venosa y úlcera arterial de extremidad inferior?

- A)** La venosa es distal y la arterial es proximal
- B)** La venosa es perimaleolar medial, poco dolorosa; la arterial es distal, muy dolorosa
- C)** La venosa solo aparece en diabéticos
- D)** La arterial tiene fondo granulante y bordes irregulares
- E)** No hay diferencias clínicas significativas

PREGUNTA 3

¿Cuál es el pilar del tratamiento conservador de la insuficiencia venosa crónica?

- A)** Diuréticos orales diarios
- B)** Reposo absoluto en cama
- C)** Compresión elástica gradual
- D)** Anticoagulación crónica
- E)** AINEs de uso continuo

RESUMEN: INSUFICIENCIA VENOSA DE EXTREMIDADES INFERIORES

La insuficiencia venosa crónica es la incapacidad del sistema venoso de las extremidades inferiores para mantener un adecuado retorno venoso, generalmente por incompetencia valvular. Es una patología muy prevalente que afecta hasta al 25% de las mujeres y 15% de los hombres. Las causas incluyen insuficiencia valvular primaria, síndrome post-trombótico y compresión venosa extrínseca. El diagnóstico es clínico y se complementa con eco-Doppler venoso. Se clasifica según la escala CEAP: C0 (sin signos visibles), C1 (telangiectasias), C2 (várices), C3 (edema), C4 (cambios cutáneos como dermatitis ocre y lipodermatoesclerosis), C5 (úlceras cicatrizadas), C6 (úlceras activas). Las úlceras venosas son perimaleolares mediales, irregulares, indoloras o poco dolorosas, con fondo granulante. El tratamiento se basa en medidas generales: elevación de extremidades, ejercicio, control de peso y compresión elástica gradual que es el pilar del tratamiento conservador. Las medias de compresión de 20-30 mmHg son primera línea. Los procedimientos incluyen ablación térmica con láser o radiofrecuencia, escleroterapia y cirugía de stripping para la vena safena incompetente. Las úlceras venosas se manejan con compresión multicapa, curación avanzada y corrección del reflujo venoso subyacente.